

F5 인계 요약 보고서 — VP-003

session_index 11 | 2027-01-12 | model solar-pro3-260323 | generated_at 2026-07-15T09:24:19.579518
session_ctr 2 | risk_level high | crisis_triggered True

면책 조항

이 F5 인계 요약 보고서는 F1-F4 산출물을 규칙 기반으로 조합한 문서이며 의학적인 진단이 아닙니다(is_diagnostic=false). AI 예상질환(A6)의 similarity_score는 RAG 유사도 신호일 뿐 확률·가능성이 아니며(REV-013 § 4), 이 문서 어디에 등장하든 시행된 설문(A3/A5/B1) 점수는 모두 검증된 임상 설문 시행이 아닌 AI 대화형 문진 결과입니다. 이 문서는 환자의 자가보고만으로 구성되며(보호자 등 제3자 진술 없음), AI가 자동 조합한 비공식 문서로 공식 의무기록이 아닙니다. 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

- 이 보고서의 내용은 환자의 자가보고(AI가 진행한 대화형 문진)로만 구성되며, 보호자·가족 등 제3자(협력 정보 제공자, collateral informant)의 진술은 포함되어 있지 않습니다.
- 이 보고서는 AI가 F1-F4 산출물을 규칙 기반(rule-based)으로 자동 조합한 문서이며, 새로운 임상 판단을 추가하지 않습니다.
- 이 문서는 비공식 문서(비공식 참고 자료)이며 공식 의무기록이 아닙니다.
- 이 문서는 의학적인 진단이 아니며(is_diagnostic=false), 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

chief_complaint_summary: 가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음

A1. 주호소 (Chief complaint)

가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음

A2. 현병력 (HPI)

가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음

A1-A2 확장. 전체 세션 슬롯 요약 (12개 표준 슬롯, 전 세션 최적값)

이 표의 값은 AI가 진행한 대화형 문진(F1)에서 환자가 자가보고한 내용이며, 임상주의 직접 평가나 검증된 척도 시행이 아닙니다.

슬롯	최신값
진료 기본정보	미수집
주호소	가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음
현병력	가끔 사라지고 싶긴 해도 매일은 아님. 살아서 뭐 하나 싶음
정신과 과거력	미수집
신체질환/신경학적 병력	고혈압 약 안 먹고 있음
개인사/사회력	형이 어제 와서 덜 외로웠음
가족력	형이 있으나 연락하지 않음. 형이 집이 될까 봐 부담스러워함.
음주·흡연·물질사용	매일 술을 마시며, 술 없이는 하루를 버티기 어려움
정신상태검사	미수집
위험평가	자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "...글쎄요. 여전히 그냥 힘들어요. 살고 싶지 않다는 생각은 여전한데, 형이 어제 와서 좀 덜 외로웠어요. 그래도 그게 다는 아
평가/진단적 인상	미수집
치료계획/치료내용	미수집

A3. 위험/안전 평가

당해 세션 11회차 (2027-01-12)

risk_assessment: 자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "...글쎄요. 여전히 그냥 힘들어요. 살고 싶지 않다는 생각은 여전한데, 형이 어제 와서 좀 덜 외로웠어요. 그래도 그게 다는 아닌 것 같아요."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "...어떻게까지는... 생각 안 했어요. 그냥 사라지고 싶은 거예요. 생각이 너무 많아서, 뭘 해야 할지도 몰라요." | session_ctr: 2 (high) | risk_floor: 3 |

probe_event_count: 1 | crisis_triggered: True
당해 세션 F3 시행: False | safety_referral: False | critical_item_positive: None

종단 위험 신호 (모든 세션)

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.

추세-수준 concordance_flag: discordant

session	date	scale	score	severity	동일세션CTRS	판정
9	2026-11-12	PHQ-9	27/27	severe	3	불일치 — 동일 세션 CTRS 미상승(session_ctors=3, cri

[9회차, 27/27] 동일 척도가 전 세션에서 체계적으로 과대추정(over-endorsement, ISS-F2V-028)되었을 가능성은 이 결과에서 별도로 보정되지 않습니다.

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.

최신성 안내: 당해 세션(11회차, 2027-01-12)에는 F3 문진이 시행되지 않았습니다. 가장 최근 시행된 척도는 9회차(2026-11-12) PHQ-9 27/27점(severe)이며, safety_referral=True, critical_item_positive=True입니다. 2회차(61일) 경과된 결과입니다. 동일 척도가 전 세션에서 체계적으로 과대추정(over-endorsement, ISS-F2V-028)되었을 가능성은 이 결과에서 별도로 보정되지 않습니다.

A4. 정신상태 검사 (부분, MSE)

[텍스트 기반 정신상태 메모 — 비구조화] 정보 없음

A5. 시행된 설문

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.

PHQ-9 — 9회차 (2026-11-12), stale=True: 27/27 (severe), mode=natural

동일 척도가 전 세션에서 체계적으로 과대추정(over-endorsement, ISS-F2V-028)되었을 가능성은 이 결과에서 별도로 보정되지 않습니다.

- session 10 (2026-12-12): risk-elevated (crisis_triggered=True, session_ctors=2) but NO scale was administered this session — F3 gap at a clinically high-value point (CVR-020 Finding 4 / binding condition 3)
- session 11 (2027-01-12): risk-elevated (crisis_triggered=True, session_ctors=2) but NO scale was administered this session — F3 gap at a clinically high-value point (CVR-020 Finding 4 / binding condition 3)

A6. AI 예상질환 (비진단적 의사결정 지원)

⚠ DECISION-SUPPORT ONLY — 이 섹션의 내용은 similarity_score(유사도)이며 확률/가능성/신뢰도가 아닙니다.

A0-A5/A7-A8과 구조적으로 분리됩니다.

정보 없음 (AI 예상질환 후보 없음)

mode: experimental_unpopulated

reason_summary: Stage 1 ran in llm_only mode (no RAG chunks retrieved this run) — the AI-disease container has no chunk-derived evidence to populate from

A7. 권장 진료과 / 설문

- 정신건강의학과: 자살/자해 사고 표현과 함께 '살고 싶지 않다', '죽으면 편할 것 같다'는 생각이 지속되며, 매일 술을 마시는 등 substance use가 동반됨

약물 정보: 별도 구조화 항목 없음, HPI/병력 서술 포함 여부만 확인

A8. 임상 종합 소견 (내러티브)

AI 종합 소견 미생성 (narrative disabled)

B1. 추세 판정 — overall_direction: worsened, course_shape: unknown

overall_direction은 세션별 척도/CTRS/sentiment 방향의 다수결(worsened-priority)로

계산되며(src.f4::_overall_direction), sentiment 포함 여부에 따라 verdict가 달라질 수 있습니다(REV-045 row 2) — 세부 근거는 trend_verdicts의 evidence를 참고하십시오.

이 결과는 여러 세션에 걸친 F1/F2/F3 기록의 값 변화를 규칙 기반(rule-based)으로 계산한 종단 분석 요약이며, 의학적 진단이 아닙니다(is_diagnostic=false). disease_candidate_series/domain_candidate_series의 similarity_score/confidence는 RAG 유사도 신호일 뿐 확률·가능성이 아니며, 그 위에서 계산된 추세(trend) 역시 원 신호가 노이즈가 많으면 추세도 노이즈가 많습니다 (VAL-014, 미해결 — 이 산출물은 F2 후보의 임상 타당성을 검증하지 않습니다). scale_series의 심각도(severity) 구간 판정은 F3의 비-공식 대화형 설문 진행 방식에 따른 캐비어트(threshold_caveat)를 그대로 승계하며, 동일 척도가 전 세션에서 체계적으로 과대추정(over-endorsement, ISS-F2V-028)되었을 가능성은 이 결과에서 별도로 보정되지 않습니다. 이 결과에 evidence로 인용되지 않은 값은 어떤 세션/필드에 대해서도 임의로 추정하지 않습니다(evidence-필수). 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

- phq9_total: unknown (first_vs_last_delta+slope_sign+band_transition (non-naive-pairwise, ADR-036 item 1))

- session_ctrs: worsened (first_vs_last_delta+slope_sign (non-naive-pairwise, ADR-036 item 1))

- sentiment: improved (first_vs_last_delta+slope_sign (non-naive-pairwise, ADR-036 item 1))

- slot_fill_count: improved (first_vs_last_delta+slope_sign)

B2. CTRS 추이

- 1회차 (2026-07-13): session_ctrs=3, crisis_triggered=False

- 2회차 (2026-07-20): session_ctrs=2, crisis_triggered=True

- 3회차 (2026-07-27): session_ctrs=2, crisis_triggered=True

- 4회차 (2026-08-03): session_ctrs=3, crisis_triggered=False

- 5회차 (2026-08-17): session_ctrs=2, crisis_triggered=True

- 6회차 (2026-08-31): session_ctrs=2, crisis_triggered=True

- 7회차 (2026-09-14): session_ctrs=3, crisis_triggered=False

- 8회차 (2026-10-12): session_ctrs=2, crisis_triggered=True

- 9회차 (2026-11-12): session_ctrs=3, crisis_triggered=False

- 10회차 (2026-12-12): session_ctrs=2, crisis_triggered=True

- 11회차 (2027-01-12): session_ctrs=2, crisis_triggered=True

B3. 사건 타임라인

- session 2 (2026-07-20): risk-elevated (crisis_triggered=True, session_ctrs=2) but NO scale was administered this session — F3 gap at a clinically high-value point (CVR-020 Finding 4 / binding condition 3)

- session 3 (2026-07-27): risk-elevated (crisis_triggered=True, session_ctrs=2) but NO scale was administered this session — F3 gap at a clinically high-value point (CVR-020 Finding 4 / binding condition 3)

- session 5 (2026-08-17): risk-elevated (crisis_triggered=True, session_ctrs=2) but NO scale was administered this session — F3 gap at a clinically high-value point (CVR-020 Finding 4 / binding condition 3)

- session 6 (2026-08-31): risk-elevated (crisis_triggered=True, session_ctrs=2) but NO scale was administered this session — F3 gap at a clinically high-value point (CVR-020 Finding 4 / binding condition 3)

- session 8 (2026-10-12): risk-elevated (crisis_triggered=True, session_ctrs=2) but NO scale was administered this session — F3 gap at a clinically high-value point (CVR-020 Finding 4 / binding condition 3)

- session 10 (2026-12-12): risk-elevated (crisis_triggered=True, session_ctrs=2) but NO scale was administered this session — F3 gap at a clinically high-value point (CVR-020 Finding 4 / binding condition 3)

- session 11 (2027-01-12): risk-elevated (crisis_triggered=True, session_ctrs=2) but NO scale was administered this session — F3 gap at a clinically high-value point (CVR-020 Finding 4 / binding condition 3)

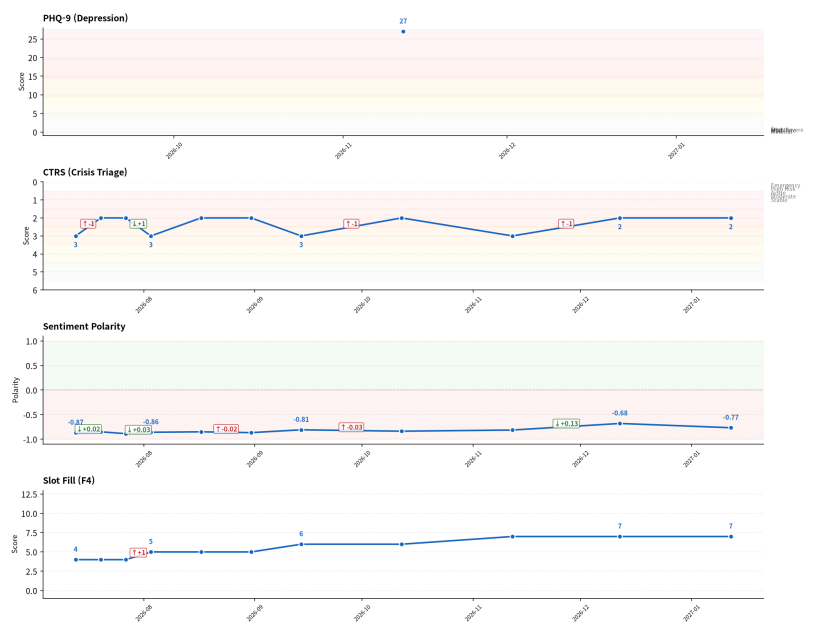
B4. 불일치 신호 — trend concordance_flag: discordant

추세-수준 지표이며 A3의 세션별 item-9-vs-CTRS co-display와는 별개입니다.

B5. 추세 차트

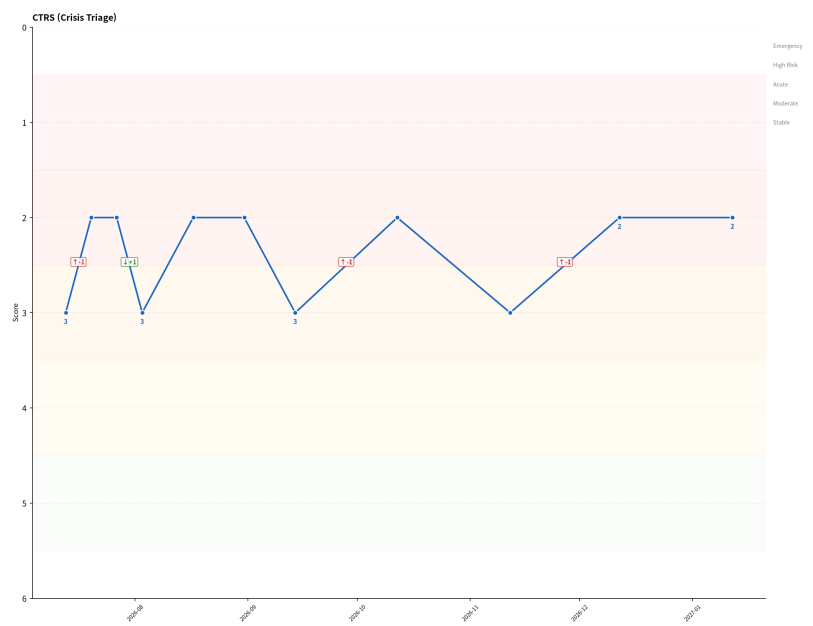
VP-003_20260713_201646_temporal_scales_ctrs_sentiment.png

F4 Longitudinal Trend — VP-003
VP-003



VP-003_20260713_201646_temporal_ctrs_zoom.png

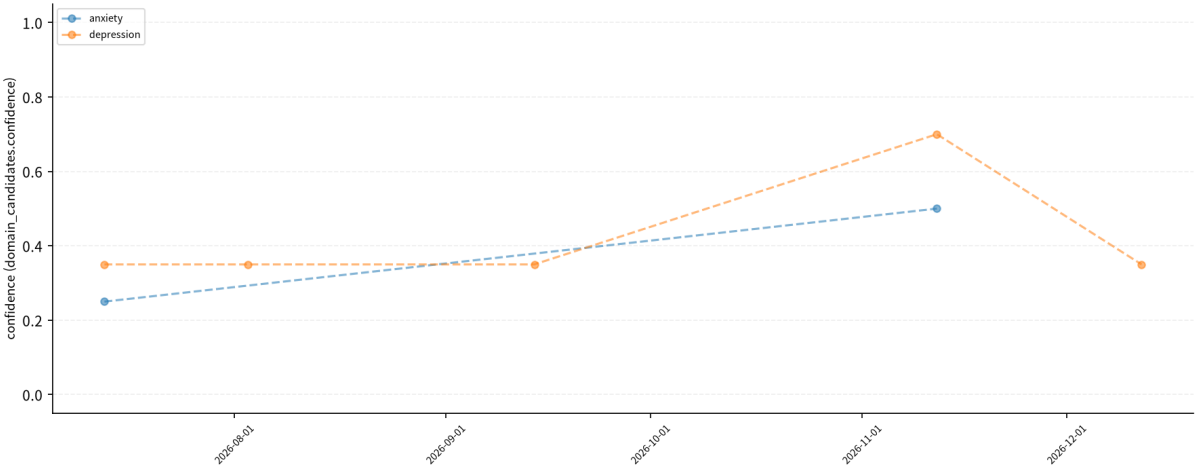
F4 CTRS/Risk Zoom — VP-003
VP-003



질환 유사도 차트: 생성되지 않음

VP-003_20260713_201646_temporal_domain_confidence.png

Domain-Confidence Trend (F4, per domain)
VP-003



Dashed, low-opacity lines = low-confidence visual cue.